Rx

ROTAVAC

(Vắc xin phòng Rotavirus)

"Để xa tầm tay trẻ em"
"Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng"
"Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc"

M.S.D.N:0101150040-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH
Q.BẮC TỪ LIÊM - T.P HÀ NỘI

1. Mô tả

Rotavac là vắc xin đơn giá có chứa hỗn dịch Rotavirus 116E sống, giảm độc lực được nuôi cấy trên tế bào vero. Rotavirus là virus RNA kép của chi Reoviridae. Rotavirus được phân loại trong hệ thống phân loại kép dựa trên hai protein trên bề mặt của virus mà phân thành các loại G và P. Dựa vào danh pháp này, Rotavirus 116E được phân loại là G9P[11]. Một liều đơn ROTAVAC của người là 0,5 mL có chứa không ít hơn $10^{5.0}$ FFU Rotavirus 116E sống.

2. Thành phần

Mỗi lọ vắc xin 0,5 ml chứa:

Thành phần dược chất	Hàm lượng
Rotavirus 116E sống, giảm độc lực, được nuôi cấy trên tế bào vero	NLT $10^{5.0}$ FFU
Thành phần tá dược	Hàm lượng
Potassium Phosphate monobasic	0,258 mg
Potassium Phosphate dibasic	0,625 mg
Sucrose	37,31mg
Potassium L-glutamate monohydrate	1,0 mg
Neomycin sulphate	15µg
Kanamycin sulphate	15µg
Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DMEM)	4,4 mg
Nước cất pha tiêm	v.đ 0,5ml

3. Dạng bào chế:

Dung dịch uống.

Vắc xin ở dạng chất lỏng trong không màu hoặc có màu hồng vàng nhạt.

4. Chỉ định

Vắc xin Rotavac được chỉ định để phòng ngừa viêm dạ dày – ruột do rotavirus ở trẻ nhỏ. Vắc xin được dùng cho trẻ từ 6 tuần tuổi với liệu trình sử dụng 3 liều, khoảng cách giữa mỗi liều ít nhất là 4 tuần. Liệu trình 3 liều phải hoàn thành trước khi trẻ được 34 tuần tuổi.

5. Liều dùng và cách dùng:

Đường dùng: Dùng đường uống, không được trộn với bất kỳ dung dịch hay vắc xin nào khác. Không được pha loãng hay cho thêm nước.

Liệu trình: Uống tất cả 3 liều:

- Liều 1: Khi trẻ từ 6 tuần tuổi
- Liều 2: cách liều 1 tối thiểu 4 tuần

- Liều 3: cách liều 2 tối thiểu 4 tuần. Tuy nhiên liều 3 phải uống trước khi trẻ được 34 tuần tuổi.

Vắc xin Rotavac có thể dùng đồng thời với các vắc xin bạch hầu - uốn ván - ho gà (DTP), vắc xin phòng viêm gan B và vắc xin phòng bại liệt uống.

Cần phải nhấn mạnh rằng trẻ được uống liều đầu tiên bằng Rotavac thì nên uống liều thứ 2, thứ 3 cũng bằng Rotavac.

Cách dùng:

Vắc xin nên được rã đông hoàn toàn (tới dạng lỏng) trước khi sử dụng

Rotavac chỉ dùng đường uống. **KHÔNG ĐƯỢC TIÊM ROTAVAC**

Trong các thử nghiệm lâm sàng, hiếm quan sát thấy hiện tượng nhổ hoặc trớ khi uống vắc xin (< 0.5%), trong trường hợp này không cần uống liều thay thế. Tuy nhiên, nếu trẻ nhổ hoặc trớ ra phần lớn lượng vắc xin đã uống vào thì nên uống ngay liều vắc xin thay thế. Các liều tiếp theo vẫn dùng theo đúng liệu trình.

Không hạn chế thức ăn hoặc nước uống của trẻ, kể cả sữa mẹ trước hoặc sau khi uống vắc xin.

Không có bằng chứng cho thấy sữa mẹ làm giảm khả năng bảo vệ của Rotavac chống lại rotavirus gây viêm dạ dày- ruột do đó nên tiếp tục cho trẻ bú mẹ trong thời gian uống vắc xin.

6. Chống chỉ định

Không được dùng vắc xin trong các trường hợp:

- Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của vắc xin
- Những trẻ xuất hiện các triệu chứng giống mẫn cảm sau khi dùng 1 liều Rotavac thì không nên dùng các liều Rotavac tiếp theo.
- Những trẻ bị rối loạn miễn dịch kết hợp trầm trọng (SCID).
- Trẻ có tiền sử bị lồng ruột

7. Cảnh báo đặc biệt và thận trọng khi dùng

Chưa có dữ liệu về tính an toàn và hiệu quả được ghi nhận từ các thử nghiệm lâm sàng liên quan đến việc sử dụng ROTAVAC ở những trẻ bị suy giảm miễn dịch, trẻ sơ sinh nhiễm HIV hoặc trẻ sơ sinh bị viêm dạ dày ruột mãn.

Việc sử dụng ROTAVAC có thể được xem xét thận trọng đối với trẻ nhỏ bị suy giảm miễn dịch và trẻ sơ sinh tiếp xúc gần gũi với người có suy giảm miễn dịch, nếu bác sĩ cho rằng việc sử dụng vắc xin có thể gây ra nguy cơ lớn hơn

Hoãn sử dụng vắc xin cho trẻ đang bị nhiễm trùng cấp tính hoặc sốt cao, sốt nhẹ và nhiễm khuẩn đường hô hấp nhẹ không phải là chống chỉ định

Các dữ liệu đã được công bố cho thấy nguy cơ mắc bệnh lồng ruột tăng lên sau khi sử dụng các liều vắc xin rotavirus đặc biệt là sau liều đầu tiên (Báo cáo của WHO, tháng 1 năm 2013, http://www.who.int/wer/2013/wer8805.pdf?ua=1).

Dữ liệu an toàn từ các thử nghiệm lâm sàng của ROTAVAC cho thấy nguy cơ bị lồng ruột không tăng lên khi dùng ROTAVAC so với nhóm dùng giả dược (Placebo). Tuy nhiên, để thận trọng, các cán bộ y tế nên lưu ý theo dõi các dấu hiệu của bệnh lồng ruột, ví dụ như: đau bụng,

nôn liên tục, phân có máu, chướng bụng. Phụ huynh /người chăm sóc nên kịp thời thông báo các triệu chứng đó cho cán bộ y tế.

Viêm dạ dày ruột do Rotavirus (RVGE) với Genotype của chủng vắc xin, G9P[11].

Hai mươi hai trẻ bị viêm dạ dày ruột do rotavirus G9P[11] xảy ra sau khi sử dụng 13.296 liều ROTAVAC (khoảng 1 trường hợp trong 600 liều); 20 trường hợp xảy ra sau liều thứ nhất, 2 trường hợp sau liều thứ hai, không có trường hợp nào mắc phải sau liều thứ 3 trong suốt thời gian theo dõi. Không có trường hợp viêm dạ dày ruột nghiêm trọng nào có liên quan với G9P[11]. Có thể có hai cách giải thích: nguyên nhân do vắc xin là hiếm gặp và hầu hết viêm dạ dày ruột nhẹ; hoặc G9P[11] đã được phát hiện trong trường hợp viêm dạ dày ruột do các mầm bệnh không xác định khác.

Tương tự như các vắc xin khác, ROTAVAC không bảo vệ trẻ chống lại được hoàn toàn viêm dạ dày – ruột do rotavirus hoặc viêm dạ dày – ruột do các tác nhân khác.

Không có dữ liệu để hỗ trợ sử dụng Rotavac cho phòng bệnh sau phơi nhiễm.

8. **Phụ nữ có thai và cho con bú:** vắc xin chỉ dùng cho trẻ nhỏ, không dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú.
9. **Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc:** Không áp dụng vì vắc xin chỉ sử dụng cho trẻ nhỏ

10. Tương tác thuốc

Nghiên cứu so sánh việc dùng vắc xin OPV cùng với Rotavac và dùng OPV cùng với giả dược, các kết quả cho thấy việc tạo miễn dịch đáp ứng với tất cả 3 serotype của bệnh bại liệt ở 2 nhóm là tương đương.

Trong nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng pha III, đánh giá so sánh dùng giả dược và dùng 3 liều Rotavac đồng thời với các vắc xin thông thường cho trẻ nhỏ: DTwP, *Haemophilus Influenzae* týp b, vắc xin viêm gan B và vắc xin OPV được sử dụng lúc 6-7 tuần tuổi; ≥ 10 tuần và ≥ 14 tuần tuổi. Các kết quả cho thấy không có sự khác biệt đáng kể giữa nhóm dùng Rotavac và nhóm dùng giả dược về các tác dụng không mong muốn gặp phải.

Trong nghiên cứu pha IV, đánh giá việc sử dụng 3 liều Rotavac theo 3 nhóm: dùng đồng thời với dung dịch đệm, Rotavac uống sau dung dịch đệm 5 phút, không dùng dung dịch đệm. Các nhóm này đều được dùng đồng thời với các vắc xin thông thường cho trẻ nhỏ: DTwP, *Haemophilus Influenzae* týp b, vắc xin viêm gan B và vắc xin OPV. Các kết quả cho thấy không có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm về các tác dụng không mong muốn gặp phải.

11. Tác dụng không mong muốn

Dữ liệu an toàn từ các thử nghiệm pha I-III của ROTAVAC được đưa ra dưới đây. Nhìn chung các trường hợp được báo cáo là tương tự như những báo cáo trong các thử nghiệm lâm sàng của các vắc xin rotavirus khác.

Trong nghiên cứu giai đoạn Ib/IIa tiến hành trên vắc xin ngừa rotavirus đường uống (ORV) 116E ở Ấn Độ với 369 trẻ ở độ tuổi 6-8 tuần, không có phản ứng bất lợi đáng kể nào được chứng minh là có liên quan tới ORV 116E. Các tác dụng không mong muốn thông thường được báo cáo bao gồm sốt, nôn mửa và tiêu chảy. Nghiên cứu hiệu quả giai đoạn 3 được thực hiện ở Ấn Độ với 6.799 trẻ sơ sinh từ 6-7 tuần tuổi, tỷ lệ các phản ứng bất lợi tức thì và các phản ứng

bất lợi nghiêm trọng là tương tự trong nhóm vắc-xin và nhóm dùng giả dược. Các tác dụng bất lợi hay gặp: sốt, nôn mửa, tiêu chảy, ho, chảy nước mũi, khó chịu và phát ban. Phản ứng bất lợi tức thì quan sát thường thấy trong vòng 30 phút sau khi uống vắc xin là nôn mửa và nhổ ra (<0,5%).

Trong thử nghiệm pha III, không có sự khác biệt nào được phát hiện giữa nhóm dùng ROTAVAC và nhóm giả dược trong các quan sát về khả năng gây phản ứng sau khi uống vắc xin. Tỷ lệ các phản ứng bất lợi sau khi uống vắc xin (sốt, tiêu chảy và nôn mửa) được ghi nhận trong giai đoạn thử nghiệm Ib/IIa, không được xác nhận trong nghiên cứu lớn pha III. Các phản ứng gặp phải với tỷ lệ thấp hơn trong giai đoạn thử nghiệm Ib/IIa, có thể là do sự sử dụng riêng biệt các vắc xin giai đoạn sơ sinh với sử dụng ROTAVAC/placebo. Thử nghiệm pha III, có tỷ lệ sốt cao hơn do đối tượng được tiêm các vắc xin thường quy ở trẻ em đồng thời với sử dụng ROTAVAC/giả dược; tuy nhiên, tần số sốt cũng tương tự giữa ROTAVAC và nhóm giả dược.

Không có các SAE liên quan đến vắc xin được báo cáo trong giai đoạn thử nghiệm Ib/IIa. Trong thử nghiệm pha III, 925 trong số 4.531 các đối tượng nhận ROTAVAC (20,4%) và 499 trong số 2,265 đối tượng nhận giả dược (22,0%) đã báo cáo một SAE. Tất cả các trường hợp được xem là không liên quan đến ROTAVAC/placebo; có 3 SAE có thể liên quan là nhiễm khuẩn huyết và viêm dạ dày ruột (GE) ở hai người nhận giả dược, nổi mày đay ở một người nhận ROTAVAC.

Không có SAE liên quan đến vắc xin được quan sát/ báo cáo.

Không có trường hợp tử vong trong 369 đối tượng trong giai đoạn thử nghiệm Ib/IIa, 42 ca tử vong xảy ra trong số các đối tượng trong giai đoạn III; 25 trong tổng số 4.531 đối tượng (0.55%) trong nhóm ROTAVAC và 17 trong số 2,265 đối tượng (0,75%) ở nhóm dùng giả dược (p = 0,3279). Không có trường hợp tử vong nào được coi là có liên quan đến việc sử dụng ROTAVAC/placebo.

Không có trường hợp lồng ruột được quan sát thấy trong giai đoạn thử nghiệm Ib/IIa. Trong giai đoạn thử nghiệm III, có sáu trường hợp bị lồng ruột được quan sát thấy trong số 4.532 người nhận ROTAVAC (0.13%) và hai trong số 2.267 người nhận giả dược (0,09%). Sự khác biệt nhỏ về số lượng đối tượng trẻ bị lồng ruột không có ý nghĩa thống kê (p = 0,7267). Không có báo cáo về trẻ bị lồng ruột trong thời gian 14 ngày sau khi chủng ngừa; trường hợp đầu tiên xác định xảy ra ở đối tượng dùng giả dược, 36 ngày sau liều thứ ba. Trường hợp đầu tiên được báo cáo trong số những người nhận ROTAVAC xảy ra 112 ngày sau liều thứ ba. G1P[8] đã được xác định trong phân của đối tượng này. Tất cả các trường hợp bị lồng ruột đã được tháo lồng bằng hơi hoặc dùng dung dịch bari; không phải can thiệp phẫu thuật và không gây tử vong.

Không có trường hợp lồng ruột nào được báo cáo trong nghiên cứu pha IV.

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới tháng 1 năm 2013, về vắc xin Rotavirus, lợi ích của việc sử dụng vắc xin để phòng ngừa tiêu chảy nghiêm trọng và tử vong do nhiễm rotavirus vượt xa nguy cơ bị lồng ruột.

Với trẻ đẻ non và trẻ sơ sinh bị nhiễm virus HIV: chưa có nghiên cứu trên nhóm đối tượng này.

Dữ liệu hậu mãi

Phân tích các dữ liệu nhận được cho thấy các tác dụng không mong muốn hay gặp sau khi sử dụng ROTAVAC là sốt, dễ cáu kỉnh và ói mửa, theo sau là tiêu chảy và phát ban. Không có SAE và không có trường hợp lồng ruột nào được báo cáo.

Dữ liệu an toàn tích hợp

Hồ sơ an toàn được trình bày dưới đây dựa trên dữ liệu từ các thử nghiệm lâm sàng được tiến hành với ROTAVAC. Trong tổng số tám thử nghiệm lâm sàng khoảng 30.000 liều ROTAVAC được dùng cho khoảng 10.000 trẻ sơ sinh. Trong phân tích gộp từ tất cả các thử nghiệm lâm sàng trong đó ROTAVAC được dùng đồng thời với các vắc xin thông thường của trẻ nhỏ, các phản ứng bất lợi (được thu thập sau 28 ngày sử dụng vắc xin) như sốt, tiêu chảy, nôn mửa, chán ăn, khó chịu, ho được quan sát và coi là có thể liên quan đến Rotavac hoặc có thể do vắc xin dùng đồng thời.

Các tác dụng không mong muốn gặp phải được liệt kê theo tần suất như sau:

Rất thường gặp: ≥ 10%

- Toàn thân: sốt
- Hệ tiêu hóa: tiêu chảy
- Hệ hô hấp: ho

Thường gặp: ≥ 1% và < 10%

- Hệ thần kinh: kích thích, quấy khóc
- Hệ tiêu hóa: Nôn
- Da: nổi ban

Ít gặp ≥ 0,1% và < 1%

- Hệ tiêu hóa: mất cảm giác ngon miệng, bỏ ăn

Hiếm gặp: ≥ 0,01% và < 0,1%

- Viêm dạ dày ruột cấp tính, viêm phổi, lồng ruột.

12. Quá liều và cách xử trí

Không có báo cáo về sử dụng quá liều

13. Các đặc tính dược lực học

Nhóm điều trị: vắc xin

ATC code: J07BH01

Hiệu quả bảo vệ

Nghiên cứu lâm sàng đa trung tâm đã được tiến hành ở Ấn Độ để đánh giá hiệu quả của ROTAVAC để phòng ngừa viêm dạ dày - ruột (RVGE) nặng do Rotavirus. Dữ liệu về hiệu quả của vắc xin đã được đưa ra trong năm đầu tiên và năm thứ hai. Kết quả của hai phân tích này là tương tự, cho thấy hiệu quả của vắc xin vẫn duy trì vào năm thứ hai.

Hiệu quả của vắc xin để phòng ngừa viêm dạ dày - ruột nghiêm trọng là 56,4% [95% CI: 36,6; 70,1] và 34,6 [95% CI: 19.7; 46.6] cho RVGE với bất kỳ mức độ nghiêm trọng nào trong năm

đầu tiên. Trong cùng một nghiên cứu, hiệu quả chống lại RVGE nghiêm trọng trong năm thứ hai là 49% (95% CI 17,5, 68,4) và 35,0% [95% CI 19,1, 47,7] đối với RVGE của bất kỳ mức độ nghiêm trọng nào.

Đối với viêm dạ dày ruột phải yêu cầu nhập viện do bất kỳ nguyên nhân nào, ROTAVAC đã ngăn ngừa 47,7% (95% CI: 24,5, 63,8) các trường hợp phải nhập viện do viêm dạ dày ruột trong thời gian ≥ 24 giờ. ROTAVAC cũng có hiệu quả chống lại viêm dạ dày ruột nặng do bất kỳ nguyên nhân nào (VE = 18,6% [95% CI 1,9, 32,3])

Đáp ứng miễn dịch

Khả năng tạo miễn dịch của ROTAVAC được đánh giá dựa vào hiệu giá kháng thể IgA (bằng phương pháp ELISA). Trong giai đoạn thử nghiệm Ib/IIa đáp ứng huyết thanh học (tăng ≥ 4 lần) được thấy ở 89,7% người nhận ROTAVAC (so với 28,1% người nhận giả dược). Trong thử nghiệm pha III, phản ứng huyết thanh học được quan sát sau liều thứ ba của ROTAVAC là 40,3% so với 18,4% ở nhóm dùng giả dược.

Tóm lại: Trong giai đoạn III hiệu quả thử nghiệm lâm sàng ở trẻ sơ sinh, ROTAVAC

- Có hiệu quả trong việc phòng ngừa viêm dạ dày – ruột nghiêm trọng do rotavirus
- Có hiệu quả trong việc ngăn ngừa RVGE nghiêm trọng trong năm đầu và năm thứ hai
- Có hiệu quả trong việc ngăn ngừa bất kỳ mức độ nghiêm trọng nào của RVGE trong năm thứ nhất và năm thứ hai
- Cung cấp bảo vệ rộng rãi chống lại các kiểu gen RV lưu hành phổ biến nhất ở Ấn Độ.
- Giảm tỷ lệ nhập viện và điều trị bù nước do viêm dạ dày ruột gây ra do bất kỳ nguyên nhân nào

Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III:

Trong thử nghiệm nghiên cứu pha III mù đôi, có đối chứng trên 1356 trẻ từ 6-7 tuần tuổi sử dụng đồng thời vắc xin Rotavac cùng với OPV (3 týp 1,2,3) và vắc xin 5 trong 1 (DTwP, Hep B và Hib)

Các tác dụng không mong muốn gặp phải phổ biến là: sốt, nôn, tiêu chảy, ho, lờ đờ, sổ mũi, khó chịu và phát ban. Không có các SAE liên quan đến vắc xin, không có trường hợp lồng ruột nào được báo cáo.

Các thống kê lâm sàng tương tự đã được thiết lập trên cả ba lô sản xuất.

Ba liều Rotavac có thể được dùng một cách an toàn cùng với 3 liều vắc xin 5 trong 1 (DTwP, Hep B và Hib), 3 liều OPV mà không làm giảm đáp ứng kháng thể của từng thành phần của các vắc xin này. Rotavac được dung nạp tốt cùng với các vắc xin thông thường khác cho trẻ. Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê trong tỷ lệ chuyển đổi huyết thanh IgA và GMT giữa 3 lô nghiên cứu.

Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn IV:

Trong một thử nghiệm lâm sàng riêng biệt, đánh giá vai trò của hệ đệm trong 900 đối tượng trên ba nhóm: ROTAVAC với hệ đệm (dung dịch đệm được dùng 5 phút trước khi uống vắc xin (300)), ROTAVAC không có đệm (300) và ROTAVAC được dùng đồng thời với đệm (300).

Trong thử nghiệm lâm sàng này, các vắc xin OPV và vắc xin 5 trong 1 (DTwP, Hep B và Hib) được dùng đồng thời. Không có sự khác nhau có ý nghĩa thống kê về các tác dụng không mong muốn giữa các nhóm. Sốt, tiêu chảy, nôn mửa, ho, lạnh và khó chịu là những tác dụng phụ thường gặp nhất. Sự phân bố các tác dụng không mong muốn như nhau trong cả ba nhóm điều trị.

Không có SAE liên quan đến vắc xin, không có trường hợp lồng ruột nào được quan sát / báo cáo.

Có một trường hợp tử vong được báo cáo trong thử nghiệm giai đoạn IV không liên quan đến việc sử dụng vắc xin.

Mẫu huyết thanh được phân tích vào ngày 0 và 84, trước tiêm chủng và sau để kiểm tra số lượng đối tượng có hiệu giá dưới 20 và ≥ 20. Theo định nghĩa chuyển đổi huyết thanh, đối với rotavirus hiệu giá IgA đặc hiệu ≥ 20 được coi là có chuyển đổi huyết thanh

Trong thử nghiệm lâm sàng này, không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa ba nhóm đối với những thông số sau đây:

- Tỉ lệ chuyển đổi huyết thanh
- Hiệu giá kháng thể trung bình
- Tỉ lệ chuyển đổi huyết thanh tăng 4 lần

14. Đặc tính dược động học: Không áp dụng

15. An toàn tiền lâm sàng:

Nghiên cứu đánh giá độc tính của vắc xin uống Rotavirus chủng 116E sống, giảm độc lực với liều lặp lại, 28 ngày trên thỏ và chuột. Sử dụng hiệu giá virus lớn hơn liều dùng cho người. Kết quả cho thấy vắc xin an toàn và không gây độc với chuột và thỏ.

16. Các dấu hiệu cần lưu ý và khuyến cáo

Không được tiêm

17. Qui cách đóng gói:

Lọ vắc xin 0,5 mL /1 lọ, hộp chứa 1 lọ kèm theo 1 đầu ống nhỏ giọt bằng nhựa.

18. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn của thuốc.

Bảo quản

Vắc xin nên được bảo quản ở nhiệt độ - 20^0C, có thể bảo quản ở nhiệt độ 2-8^0C trong 6 tháng.

Vận chuyển:

Vắc xin được vận chuyển ở nhiệt độ 2 – 8^0C với đá gel đông lạnh - 20^0C.

Hạn dùng: 5 năm kể từ ngày sản xuất ở điều kiện bảo quản -20^0C và 6 tháng ở điều kiện bảo quản 2-8^0C.

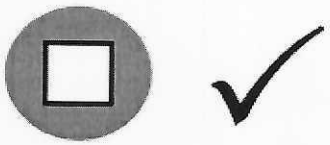
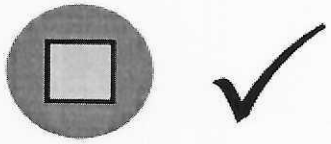
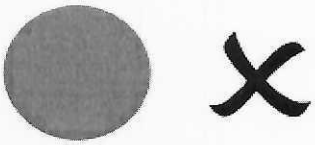
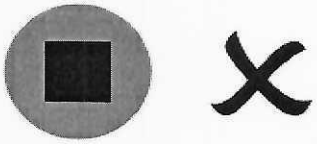
Tiêu chuẩn: tiêu chuẩn cơ sở

19. Nhà sản xuất

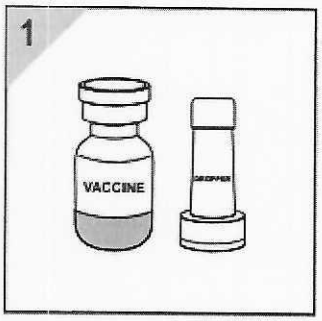
BHARAT BIOTECH INTERNATIONAL LIMITED

Địa chỉ: Sy. No. 230, 231 and 235, Genome Valley, Turkapally, Shamirpet Mandal, Medchal – Malkajgiri District – 500078, Telangana State, Ấn Độ.

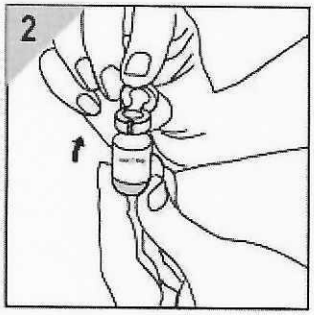
HƯỚNG DẪN ĐỌC VVM (chỉ thị nhiệt độ)

	Hình vuông bên trong sáng màu hơn vòng tròn bên ngoài. **Được phép dùng nếu vắc xin không quá hạn sử dụng.**
	Hình vuông bên trong vẫn sáng màu hơn vòng tròn bên ngoài. **Được phép dùng nếu vắc xin không quá hạn sử dụng.**
	**Loại bỏ:** Hình vuông bên trong cùng màu với vòng tròn bên ngoài. **Không được dùng vắc xin.**
	Hình vuông bên trong đậm màu hơn vòng tròn bên ngoài. **Không được dùng vắc xin.**

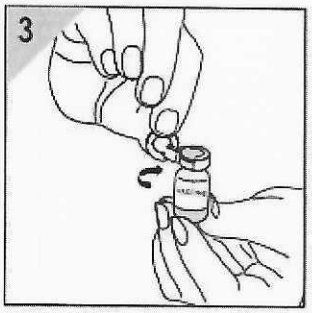
Hướng dẫn sử dụng lọ vắc xin



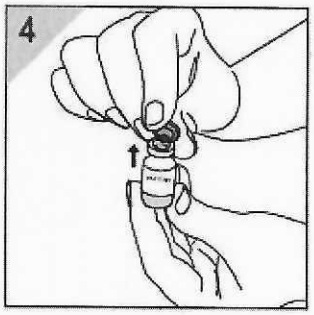
Vắc xin và ống nhỏ giọt



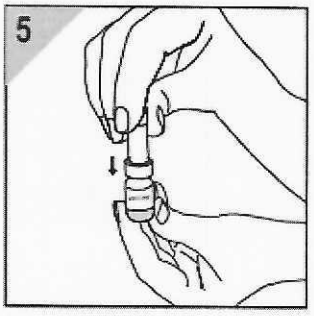
Kéo lớp nắp nhôm theo vạch đánh dấu



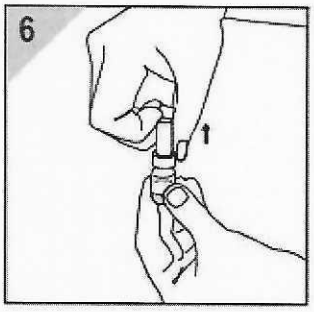
Xé bỏ lớp nắp nhôm



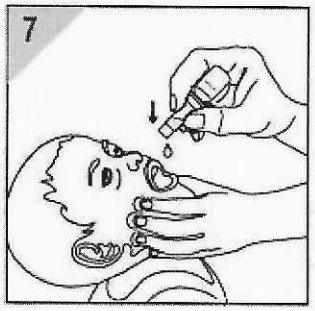
Mở nút cao su



Lắp ống nhỏ giọt vào lọ vắc xin



Mở đầu ống nhỏ giọt



Giữ ống nhỏ giọt nghiêng 45^0, bóp nhẹ đầu ống cho vắc xin vào miệng trẻ.